



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : هناء حسين احمد محمد
المحافظة : القاهرة الحي / المدينة : الزاوية الحمراء العنوان : الزاوية الحمراء
رقم البطاقة : 27905310102321 رقم التليفون : 01157074466 تاريخ تسجيل الإستمارة : 23-09-2026
العمر (تاريخ الميلاد) : 31-05-1979 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----) المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام
التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير المستشفى.
تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- د. / ----- د. / ----- د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : -----
قسم : -----
جهة العلاج : -----
نفقات : -----
ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: هناء حسين احمد محمد National ID: 27905310102321	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



جمهورية مصر العربية
بشارة عفيف النعمية

هنا

هسين احمد محمد

اش جمال الدين عبدالرحمن
الزاوية الحمراء - القاهرة

٢٧٩.٠٥٣١.٠١.٠٢٣ ٢١

LM2896842



٢٠٣٥/١١ ٢٧٩.٠٥٣١.٠١.٠٢٣٢١

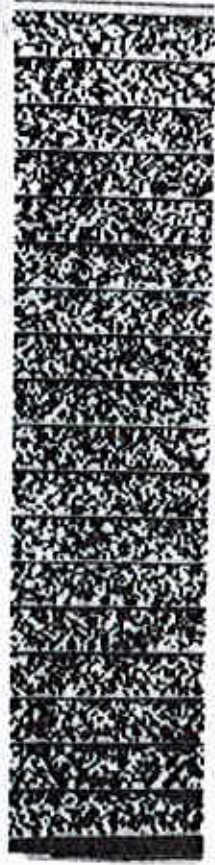
حاصله على بكالوريوس تجارة

الاسم

مسلمة

انثى

البطاقة سارية حتى ٢٠٣٣/١١/١٨



Patient Name : الأستاذة / فداء حسين احمد محمد	Request No. : 13006874
Patient No. : 27905310102321	Request Date : 14/09/2023
Path No. : 3105/23	Verification Date : 28/09/2023
Sex : Female	Financial Category : نفقة الدولة - اورثوفايتر السلام
Age : 44 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : Ali mostafa

Pathology Report

Clinical Data: Left breast cancer (post NACT) & Right breast lesion.
Nature of the specimen: Left MRM&Right WLE&Right ALND

Gross Examination:

- Procedure: Left MRM&Right WLE&Right ALND

1) Left MRM

measured 26x20x4 cm with covering skin ellipse measured 20x12cm & attached axilla 9x6 cm .

- Tumor extent : A greyish white tumour bed site
- Size: 4x2x2 cm .
- Skin involvement: Nipple & areola were unremarkable grossly .
- Distance from margins: 1 cm away from deep margin , 1.5 cm away from the skin .
- Lymph nodes number and size: 12 L.Ns up to 2.5x1 cm

2) Right WLE&ALND

adeined rubbery to firm nodule 0.8x0.5 cm, 0.3 cm from inked lateral margin, rest of breast was fibrotic

*ALND: Fibrofatty tissue 9x8 cm ,entangling 13 nodules up to 1 cm.

Microscopic examination:

Left breast:

- Histological type: No residual viable tumor tissue detected
- Ductal carcinoma in situ: No
- Skin involvement: Free nipple and areola
- Lymph node involvement: Free L.Ns (0/12)
- Resection Margins: Free margins
- Histologic response to therapy: Pathologic Complete response

2) Right breast:

histopathological examination of sections prepared from the lumpectomy specimen received reveals a benign growth made up of proliferating mammary ducts which are

Verified by :

Dr.Heba Hasan

Patient Name : الأمثلة / هاء حسن أحمد محمد
Patient No. : 27805310102321
Path No. : 3105/23
Sex : Female
Age : 44 Y
Referring Doc :

Request No. : 13008874
Request Date : 14/09/2023
Verification Date : 28/09/2023
Financial Category : نفقة الدولة - رواتب
Department : Out Patient
Registered by : All mostafa

Pathology Report

compressed and distorted. The ducts are lined by inner columnar and outer myoepithelial cells. The stroma in between is formed of dense fibrous connective tissue. There is no evidence of malignancy in sections examined

*Complete pathological response in single axillary lymph node, no viable tumor tissue (0/13)

Diagnosis:

Left MRM (post NAOT):

No residual viable tumor tissue detected.

* Free margins

* Free nipple and areola

* Free L.Ns (0/12)

* Pathologic Complete Response

* Stage : ypT0 , ypN0

Right WLE&ALND:

Intracanalicular fibroadenoma

complete pathological response in single axillary lymph node, no viable tumor tissue (0/13)

Comment: for correlation with right breast imaging findings to confirm origin of right axillary lymph node tumor

Prof. Dr. Iman Gouda

Dr. Heba Hassan

Shams University Hospitals
Radiology department



مستشفيات جامعة عين شمس
قسم الأشعة التشخيصية

Patient Name: Hanan Hussein Ahmed Mohammad

Patient ID: 10210223050720

D/T: 3/15/2023 12:49:52 PM

رجدة أحمد / أحمد طلعت للطبيب النووي

Tc^{99m} MDP whole body bone scan

History:

43-year-old patient, recently diagnosed breast cancer. For metastatic work-up.

Technique:

Whole body anterior and posterior blood-pool and delayed 3 hours scans were taken after IV injection of 20 mCi of Tc^{99m} MDP.

Findings:

Bone lesions:

An area of focal warm tracer uptake is seen at the left 5th rib anteriorly and posteriorly. Otherwise, homogenous tracer distribution through the rest of the surveyed skeleton.

Other findings:

Left breast diffuse warm tracer uptake.
Both kidneys are visualized.

Impression:

Left 5th rib area of warm tracer uptake, likely benign traumatic in nature. Otherwise, the surveyed skeleton is free from metastatic osseous deposits.

Dr. Hanan Hussein, MSc

Supervised by Dr. Mennatallah Hatem, MD.

BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND HIGH RESOLUTION ULTRASOUND

Indication:

Left breast pathologically proven carcinoma with ipsilateral proven bilateral metastatic axillary LNs on neoadjuvant therapy

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral 3D MLO DBT (Digital Breast Tomosynthesis)
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- Heterogeneous dense parenchyma (ACR C)
- Left axilla patient (increased skin thickening and coarse trabeculation)
- Left breast metastatic nodules
- No right axillary lymphadenopathy or metastatic nodules detected

Comparison with previous:

- Left axilla metastatic nodules measuring about 4.5x3.5cm
- Left breast metastatic nodules measuring about 3.5x1.5cm compared to 4.5x3.5mm
- Right 6 O'clock adenitic nodule measuring about 9x6mm
- Normal right skin thickness, and nipple-areola complex with average caliber of the retro-areolar central ducts.
- Multiple left axillary enlarged LNs with non uniform cortical thickening and effaced fatty hilum
- Nonspecific right axillary LN.

Opinion:

- Left retroareolar mass showing partial response to therapy (BIRADS 5)
- Left axilla pathological LNs showing partial response to therapy
- Right axilla complete radiological response to therapy
- Right 6 O'clock adenitic nodule (BIRADS 2)

Yours truly

Signature Dr. Walea Abdelaze

04/07/2023 3:13 PM



Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان



MDT form

A-Patient ID:

1- Name: **ملاو حسين احمد محمد**

Sex:

3- Medical number:

Female

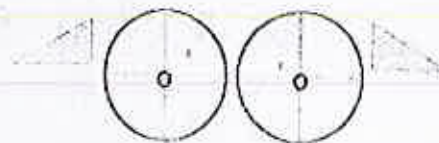
63127931

Old Med:

685/2023

2-ID number: 27905310102321

Patient Age: 44 Y



Family history

Phone

01069963909

BMI

REASON OF MDT NEW

marital status

NRS Score

GROUP

B

Date of MDT

2023-10-03

Co morbidity

Menopausal
status

PREMENOPAUSAL

Clinical data

Breast Imaging:

Mets Workup:
FREE

BX:	ER: 8/8	PR: 8/8	Her 2 Neu: 3	SISH:	KI67:
LT BREAST: IDC G 2 LT AXILLA: METASTATIC ADENOCARCINOMA (LIKELY PRIMARY MAMMARY ORIGIN)					

T 4d	N 3	M 1
---------	--------	--------

Sonomammography

RT AXILLA: METASTATIC ADENOCARCINOMA BREAST PRIMARY ORIGIN
LT BREAST 2 MALIGNANT LOOKING 4.6*3.5 CM WITH INTERNAL MICROCALCIFICATION
SUSPICIOUS LESION N AXILLARY

PATIENT HISTORY

CASE OF LT BREAST CANCER CT4N3+METS TO RT AXILLARY LN BIOPSY PROVEN
RECEIVED NACT,,TCHPX6 LAST ONE WAS ON 24/6/2023 FOR MDT
REGARDING SURGERY

MDT OUTCOME & PLAN

PORT
ADJ TAMOFEN
ZOLADEXO
TO COMPLETE 1 YEAR OF HERCEPTIN- PERJETA

MEDICAL ONCOLOGY	SIGNATURE	RADIOLOGY	
SURGERY		PATHOLOGY	
Psychiatric		Nutrition	